

	PROTOCOLO MANEJO AVANZADO DE PARO CARDIORESPIRATORIO	Código:	GCL 1.5
		Fecha:	Mayo 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Julio de 2028
		Página:	Página 1 de 19

PROTOCOLO MANEJO AVANZADO DE PARO CARDIORESPIRATORIO

**Unidad de Calidad y Seguridad del Usuario,
CESFAM Dr. Orlando Leyton A. Peralillo**

Elaborado por: Carolina Tapia Touma Laura Pérez Lucero Karolan Verdugo Muñoz	Revisado por: EU María José Solís L	Aprobado por: Dr. Cristian Cárdenas E
Cargo : Médicas EDF CESFAM Peralillo	Cargo: Referente técnico Unidad de Calidad	Cargo: Director CESFAM Peralillo
Fecha: 23/05/2025	Fecha: 26-5-2025	Fecha: 30-5-2025
Firma:  Dra. Laura Pérez Lucero Médica Cirujana Rut: 18.396.844-0  Dra. Karolan Verdugo Muñoz Médica Cirujana Rut: 19.696.638-2 RCM: 52166  Dra. Carolina Tapia Touma Médica Cirujana Rut: 18.404.022-6 RCM: 45671-3	Firma: 	Firma: 

	PROTOCOLO MANEJO AVANZADO DE PARO CARDIORESPIRATORIO	Código:	GCL 1.5
		Fecha:	Mayo 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Julio de 2028
		Página:	Página 2 de 19

I. INTRODUCCIÓN

La reanimación cardiopulmonar avanzada (RCP-A) es un conjunto de maniobras y procedimientos destinados a restaurar la circulación y respiración espontáneas en pacientes que han sufrido un paro cardiorrespiratorio (PCR). Su aplicación oportuna y adecuada puede aumentar las probabilidades de supervivencia y recuperación del paciente, por lo que es de suma relevancia que nuestro equipo de salud se encuentre preparado.

II. OBJETIVOS

a. Objetivo General.

Proveer condiciones para la entrega de acciones de salud seguras en el contexto de quien sufre un paro cardio-respiratorio, tanto adultos como pediátricos, que ocurran dentro de nuestro establecimiento.

b. Objetivo específicos.

- Estandarizar la actuación ante la ocurrencia de un PCR, promoviendo una respuesta eficiente y basada en la mejor evidencia científica disponible.
- Determinar los roles a seguir ante un PCR promoviendo una respuesta coordinada en los integrantes del equipo de salud.

III. ALCANCE

El presente protocolo rige para todos los profesionales clínicos que se desempeñan en establecimientos de salud de la comuna de Peralillo, en especial para equipo de Servicio de Urgencia Rural de Peralillo.

	PROTOCOLO MANEJO AVANZADO DE PARO CARDIORESPIRATORIO	Código:	GCL 1.5
		Fecha:	Mayo 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Julio de 2028
		Página:	Página 3 de 19

IV. DESIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES

Según desarrollo y anexo del presente protocolo se definen las siguientes responsabilidades:

Responsable	Actividad
Médico (a)	- Conocer el presente protocolo. - Liderar y organizar la reanimación cardiopulmonar de acuerdo al protocolo. - Iniciar maniobras de compresión hasta que llegue otro profesional (kinesiólogo o enfermera) o TENS deje instalada la vía venosa periférica. - Indicar drogas vasoactivas a pasar. - Realizar los registros en ficha clínica de la atención asociada a la reanimación. - Realizar la receta pertinente a los medicamentos usados una vez terminada la emergencia. - Presentar el caso vía telefónica a personal de SAMU, en caso de ser necesario. - Entregar la información pertinente a la familia directa una vez finalizada la reanimación.
TENS	- Instalación de monitor o parches de DEA - Instalación de tabla para RCP - Si no está presente enfermería, será responsable de instalación de vía venosa y administración de medicamentos. - Realizar compresiones torácicas
Enfermería	- Instalación de vía venosa - Administración de medicamentos - Apoyo en compresiones torácicas
Kinesiología	- Manejo de vía aérea que incluye inserción de

	PROTOCOLO MANEJO AVANZADO DE PARO CARDIORESPIRATORIO	Código:	GCL 1.5
		Fecha:	Mayo 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Julio de 2028
		Página:	Página 4 de 19

	cánula mayo, manipulación de mascarilla con oxígeno. - Aspiración de secreciones - Apoyo en compresiones torácicas
Según disponibilidad	- Realizar registro en pizarra durante reanimación avanzada de PCR, que debe incluir: - Hora de inicio de compresiones - Hora de administración de medicamentos - Evaluación de ritmos - Hora de aplicación de descargas en caso de ser necesarias - Hora de retorno de circulación espontánea o término de reanimación. - Esta tarea debe ser conocida por todo el personal que participa de la reanimación, para poder ser realizada según disponibilidad.

V. DEFINICIONES

Paro cardiorrespiratorio (PCR): Situación clínica que comprende un cese inesperado, brusco y potencialmente reversible de las funciones respiratorias y/o cardiocirculatoria espontáneas, produciendo una disminución brusca del aporte de oxígeno, pudiendo conducir a lesiones irreversibles.

Reanimación Cardiopulmonar (RCP): Es el conjunto de maniobras encaminadas a revertir un PCR, logrando obtener flujo sanguíneo eficiente.

Reanimación Cardiopulmonar Básica (RCP-B): Es el conjunto de acciones que comprenden la detección de la existencia de una emergencia vital, la activación de los sistemas de emergencia y las maniobras iniciales que se deben emprender hasta la llegada de personal especializado.

	PROTOCOLO MANEJO AVANZADO DE PARO CARDIORESPIRATORIO	Código:	GCL 1.5
		Fecha:	Mayo 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Julio de 2028
		Página:	Página 5 de 19

Reanimación Cardiopulmonar Avanzada (RCP-A): conjunto de intervenciones dirigidas a restablecer la circulación y respiración espontáneas en pacientes que han sufrido un paro cardiorrespiratorio. Es lo que continúa a la RCP-B, y requiere personal capacitado y equipamiento adecuado. Su aplicación sigue algoritmos basados en evidencia.

SUR: Servicio de urgencia rural

Compresiones torácicas: Movimientos que se realizan en el centro del tórax del paciente, con las manos entrelazadas, los codos completamente extendidos y las rodillas en ángulo recto a nivel de la persona reanimada para intentar restablecer la circulación espontánea.

Ventilaciones: Corresponde al apoyo para ingresar aire a los pulmones.

Reanimador: Persona capacitada en manejo de paro cardiorrespiratorio, que conoce el protocolo de reanimación, lo desarrolla y realiza los procedimientos de acuerdo a su materia o profesión.

Desfibrilador externo automático (DEA): equipo de desfibrilación que cuenta con un sistema de reconocimiento de arritmias que permite que sea utilizado por cualquier persona que enfrente un PCR.

Algoritmo RCP: figura gráfica que muestra el flujo de atención y clarifica los medicamentos a administrar y acciones a realizar frente a un paro cardiorrespiratorio.

Desfibrilación: Consiste en aplicar una descarga eléctrica controlada al corazón mediante un DEA o un monitor desfibrilador manual. Su objetivo es restaurar un ritmo cardíaco efectivo.

	PROTOCOLO MANEJO AVANZADO DE PARO CARDIORESPIRATORIO	Código:	GCL 1.5
		Fecha:	Mayo 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Julio de 2028
		Página:	Página 6 de 19

Ritmos desfibrilables: ritmos cardíacos que se benefician de una desfibrilación durante una RCP-A. Corresponden a la fibrilación ventricular (FV) y Taquicardia ventricular sin pulso (TV sin pulso)

Fibrilación ventricular (FV): Actividad eléctrica caótica del corazón, sin contracción efectiva. En el electrocardiograma se ve un patrón irregular, sin complejos QRS reconocibles.

Taquicardia ventricular sin pulso (TV sin pulso): Ritmo rápido y organizado, pero sin pulso palpable. En el electrocardiograma se ven complejos QRS anchos y rápidos.

Ritmos no desfibrilables: ritmos cardíacos que no se benefician de una desfibrilación durante una RCP-A. Corresponden a la asistolia y la actividad eléctrica sin pulso.

Asistolia: Ausencia total de actividad eléctrica por lo que no hay contracción cardíaca; se visualiza una línea plana en el monitor.

Actividad eléctrica sin pulso (AESP): ritmo cardíaco en el cual hay actividad eléctrica en el ECG, pero el corazón no genera una contracción eficaz. Puede verse un ritmo “normal” pero sin perfusión ni pulso.

Acceso intravenoso (IV): inserción de una vía en una vena periférica para administrar medicamentos y líquidos rápidamente durante la RCP avanzada.

Acceso intraóseo (IO): inserción de una aguja en la médula ósea (usualmente en la tibia o el húmero) para una vía rápida y efectiva de administración de medicamentos y líquidos cuando no se puede establecer acceso IV

Retorno de circulación espontánea (RCE): se refiere al reinicio efectivo del latido cardíaco del paciente, con generación de un pulso palpable y signos de perfusión sanguínea adecuados, posterior a un paro cardíaco y maniobras de reanimación.

	PROTOCOLO MANEJO AVANZADO DE PARO CARDIORESPIRATORIO	Código:	GCL 1.5
		Fecha:	Mayo 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Julio de 2028
		Página:	Página 7 de 19

VI. DESARROLLO DEL PROCESO

1. Conformación de un equipo de reanimación de alto rendimiento

La mayoría de los intentos de reanimación exitosos requieren que varios profesionales de la salud lleven a cabo varias intervenciones de forma simultánea. El trabajo en equipo eficaz divide la tarea, con roles y funciones bien establecidas.

2. Reconocimiento y activación del protocolo de emergencias (Anexo 1)

Reconocer y reducir al mínimo el tiempo de paro cardiorrespiratorio (PCR) es fundamental, por eso el primer eslabón de la Cadena de Supervivencia consiste en activar de inmediato el sistema local de emergencias y garantizar la llegada rápida del equipo de soporte vital.

La primera persona que presencia el evento, o que encuentra a la víctima, debe determinar en menos de 10 segundos si el paciente está en situación de urgencia vital. Para ello deberá evaluar:

1. Ausencia de respuesta a estímulos verbales o físicos.
2. Ausencia de respiración, respiración agónica o boqueo.
3. Falta de pulso carotídeo (palpándolo por al menos 5 segundos y no más de 10).

Si se confirma cualquiera de estas condiciones (o las descritas en el protocolo de “código azul”), se debe activar la alarma más cercana al suceso y/o gritar 3 veces “CÓDIGO AZUL” indicando el lugar de la ocurrencia, siguiendo las directrices locales sobre traslado y distribución del personal al iniciar la reanimación, e iniciar RCP-B.

	PROTOCOLO MANEJO AVANZADO DE PARO CARDIORESPIRATORIO	Código:	GCL 1.5
		Fecha:	Mayo 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Julio de 2028
		Página:	Página 8 de 19

3. Iniciar la RCP

- El paso inicial en el algoritmo de paro cardíaco en adultos es iniciar la RCP. En cuanto observe que el paciente no responde y no respira (o solo jadea), active el código azul, consiga un DEA, compruebe el pulso e inicie la RCP, comenzando con las compresiones torácicas.
- Conecte los parches del monitor del ECG o del DEA tan pronto como estén disponibles.
- Administre una RCP de alta calidad (Tabla 1)
- Simultáneamente el usuario debe ser trasladado a sala de reanimación SUR o sala de procedimientos en postas de salud rurales, según corresponda.

Tabla 1.

RCP de alta calidad:

- Comprimir el tórax con fuerza y rapidez, al menos 5 cm, a una velocidad de 100 a 120 por minuto.
- Permitir que el tórax se expanda por completo después de cada compresión
- Cambiar de compresores cada 2 minutos o antes si se fatigan. El cambio debe tardar solo 5 segundos.
- Reducir al mínimo las interrupciones de las compresiones a 10 segundos o menos
- Evitar una ventilación excesiva.

4. Administre oxígeno e inicie ventilaciones: se deben administrar 2 ventilaciones con bolsa mascarilla cada 30 compresiones torácicas (relación

	PROTOCOLO MANEJO AVANZADO DE PARO CARDIORESPIRATORIO	Código:	GCL 1.5
		Fecha:	Mayo 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Julio de 2028
		Página:	Página 9 de 19

30:2). En caso de existir dispositivo avanzado de vía aérea se administrarán ventilaciones 1 vez cada 6 segundos, sin interrumpir compresiones.

En el caso de pacientes de edad pediátrica, en caso de no contar con manejo avanzado de la vía aérea, se deben realizar en una proporción de 15 compresiones por 2 ventilaciones. En caso de contar con manejo avanzado de vía aérea se debe realizar una ventilación cada 3 segundos.

- 5. Compruebe el ritmo cardíaco**, para determinar si es desfibrilable (FV/TV sin pulso) o no desfibrilable (asistolia/AESP). Si hay 2 o más reanimadores disponibles, se debe mantener la RCP mientras se instalan los parches.

Ritmos desfibrilables: FV / TV sin pulso.

- a) Administre 1 descarga. La energía apropiada se determina mediante la identidad del desfibrilador: monofásico o bifásico.
 - i) Monofásico: administre una descarga única de 360 J.
 - ii) Bifásico: utilizar la energía recomendada por el fabricante. Si no conoce el intervalo de energía eficaz del dispositivo, administre la energía máxima para la primera descarga y para todas las descargas posteriores.
 - iii) En caso de pacientes pediátricos, independiente del tipo de desfibrilador, la primera descarga debe ser de 2 J/kg, la segunda descarga 4 J/kg. Si son necesarias descargas posteriores, deben ser mayores o iguales a 4 J/kg, con un máximo de 10 J/kg o la dosis para adultos.

Para garantizar la seguridad durante la desfibrilación, anuncie siempre la advertencia de administración de descarga. Establezca una advertencia con voz

	PROTOCOLO MANEJO AVANZADO DE PARO CARDIORESPIRATORIO	Código:	GCL 1.5
		Fecha:	Mayo 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Julio de 2028
		Página:	Página 10 de 19

enérgica antes de administrar cada descarga. Compruebe que no está en contacto con el paciente, la camilla u otro equipo. Verifique visualmente que nadie esté tocando al paciente o la camilla y aplique la descarga.

- b) Reinicie la RCP inmediatamente posterior a la descarga, comenzando con compresiones torácicas, durante un intervalo de tiempo de 2 minutos. Si durante este periodo hay profesionales disponibles, deben obtener un acceso IV/IO.
- c) Compruebe el ritmo: Tras 2 minutos de transcurrida la RCP, compruebe el ritmo, sin exceder los 10 segundos de pausa en las compresiones torácicas para hacerlo.
 - 1) Si el ritmo no es desfibrilable y es organizado, intente encontrar el pulso. Si tiene alguna duda sobre la presencia de éste, reanude la RCP de inmediato.
 - 2) Si el ritmo es organizado y existe pulso palpable, proceda a la atención post paro cardíaco.
 - 3) Si el ritmo no es desfibrilable y no existe pulso, continúe con la secuencia de asistolia / AESP del algoritmo.
 - 4) Si el ritmo es desfibrilable, administre una descarga y reanude la RCP inmediatamente durante 2 minutos después de la descarga.
 - 5) Recuerde solo comprobar el pulso si el ritmo cardíaco es organizado.
 - 6) Para la FV/TV sin pulso persistente, administre 1 descarga y reanude la RCP de inmediato por 2 minutos comenzando con las compresiones.
- d) Administre fármacos: Cuando haya acceso IV/IO disponible, puede administrar 1 mg de adrenalina durante la RCP después de la segunda descarga y repetir

	PROTOCOLO MANEJO AVANZADO DE PARO CARDIORESPIRATORIO	Código:	GCL 1.5
		Fecha:	Mayo 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Julio de 2028
		Página:	Página 11 de 19

cada 3-5 minutos. Para pacientes pediátricos, la dosis de adrenalina será de 0,01 mg/kg, con dosis máxima de 1 mg.

Si dispone de miembros adicionales del equipo, estos deberían anticiparse a la necesidad de fármacos y adelantar la preparación de estos.

Se puede considerar la administración de amiodarona o lidocaína en casos de FV/TV sin pulso que no responden a la desfibrilación.

- Amiodarona: puede administrar bolo IV/IO de 300 mg, después puede administrar una dosis adicional de 150 mg. En caso de pacientes pediátricos, la dosis corresponde a bolo de 5 mg/kg (la cual se puede repetir hasta 3 dosis totales)
ó
- Lidocaína: primera dosis de 1 a 1,5 mg/kg IV/IO, a continuación de 0,5 a 0,75 mg/kg EV/IO, a intervalos de 5 a 10 minutos, hasta una dosis máxima de 3 mg/kg. En caso de pacientes pediátricos se debe utilizar una dosis inicial de carga de 1 mg/kg.
- Sulfato de magnesio: se debe considerar la administración de sulfato de magnesio solo para casos de *torsades des pointes* asociados a un intervalo QT prolongado. La dosis a administrar es de 1 a 2 g IV/IO, diluidos en 10 ml, administrados en bolo IV IO, normalmente durante 5 a 20 minutos. (Anexo 2-3)

Ritmos no desfibrilables: AESP y asistolia

- Asistolia: Si el paciente no presenta actividad eléctrica distinguible y no tiene pulso, se encuentra en asistolia. Ante ello, se debe confirmar que el trazado plano en el monitor es de hecho una asistolia real, validando que no sea producto de una derivación del monitor que se encuentre desconectada, una

	PROTOCOLO MANEJO AVANZADO DE PARO CARDIORESPIRATORIO	Código:	GCL 1.5
		Fecha:	Mayo 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Julio de 2028
		Página:	Página 12 de 19

configuración de las derivaciones incorrectas o no es otro ritmo enmascarado.

- **AESP:** si el paciente muestra un ritmo organizado en el monitor pero no tiene pulso, se encuentra en AESP.

Fármacos:

- Administre 1 mg de adrenalina IV/IO, tan pronto como sea posible,
- Realice la RCP durante 2 minutos después de administrar los fármacos.
- Compruebe el ritmo: tras 2 minutos de transcurrida la RCP, sin exceder los 10 segundos de pausa en las compresiones torácicas para hacerlo.
- Si hay asistolia, repita la secuencia.
- Si hay actividad eléctrica organizada, intente palpar el pulso.
- Si no hay pulso o si tiene alguna duda respecto a la presencia de este, reanude inmediatamente la RCP durante 2 minutos, comenzando con las compresiones torácicas.
- Si detecta pulso y el ritmo es organizado, inicie los cuidados posteriores a un paro cardíaco.
- Si la comprobación del ritmo muestra un ritmo desfibrilable, reanude la RCP con compresiones torácicas mientras carga el desfibrilador y cambie a la secuencia de FV/TV sin pulso en el algoritmo. (Anexo 4-5-6)

VII. DISTRIBUCIÓN

- Dirección CESFAM Dr. Orlando Leyton A.
- Unidad de Calidad y Seguridad del Usuario.
- Jefa Sector Urbano.
- Jefa Sector Rural.
- Funcionarios/as clínicos.

	PROTOCOLO MANEJO AVANZADO DE PARO CARDIORESPIRATORIO	Código:	GCL 1.5
		Fecha:	Mayo 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Julio de 2028
		Página:	Página 13 de 19

- Servicio de Urgencia Rural Peralillo.

VIII. AUTORES.

- Carolina Tapia Touma, médica EDF.
- Laura Pérez Lucero, médica EDF
- Karolan Verdugo Muñoz, médica EDF.

IX. REFERENCIAS.

- American Heart Association. (2020). *Advanced cardiovascular life support: Provider manual* [eBook]. American Heart Association. ISBN 978-1-61669-797-6.
- Hospital San Pablo de Coquimbo. (2021). *Protocolo de reanimación cardiopulmonar adulto*. Subdirección de Gestión Clínica, Unidad de Calidad y Seguridad del Paciente. Versión 0.2.
- CESFAM José Joaquín Aguirre Ilustre Municipalidad de Calle Larga. (2023). *Protocolo de reanimación cardiopulmonar avanzada* (Código: GCL 1.5, Edición: Primera). Calle Larga, Chile.

	PROTOCOLO MANEJO AVANZADO DE PARO CARDIORESPIRATORIO	Código:	GCL 1.5
		Fecha:	Mayo 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Julio de 2028
		Página:	Página 14 de 19

X. CONTROL DE CAMBIOS.

Cambio	Fecha de cambio	Responsable del cambio (Firma)	Autoriza el cambio (Firma)

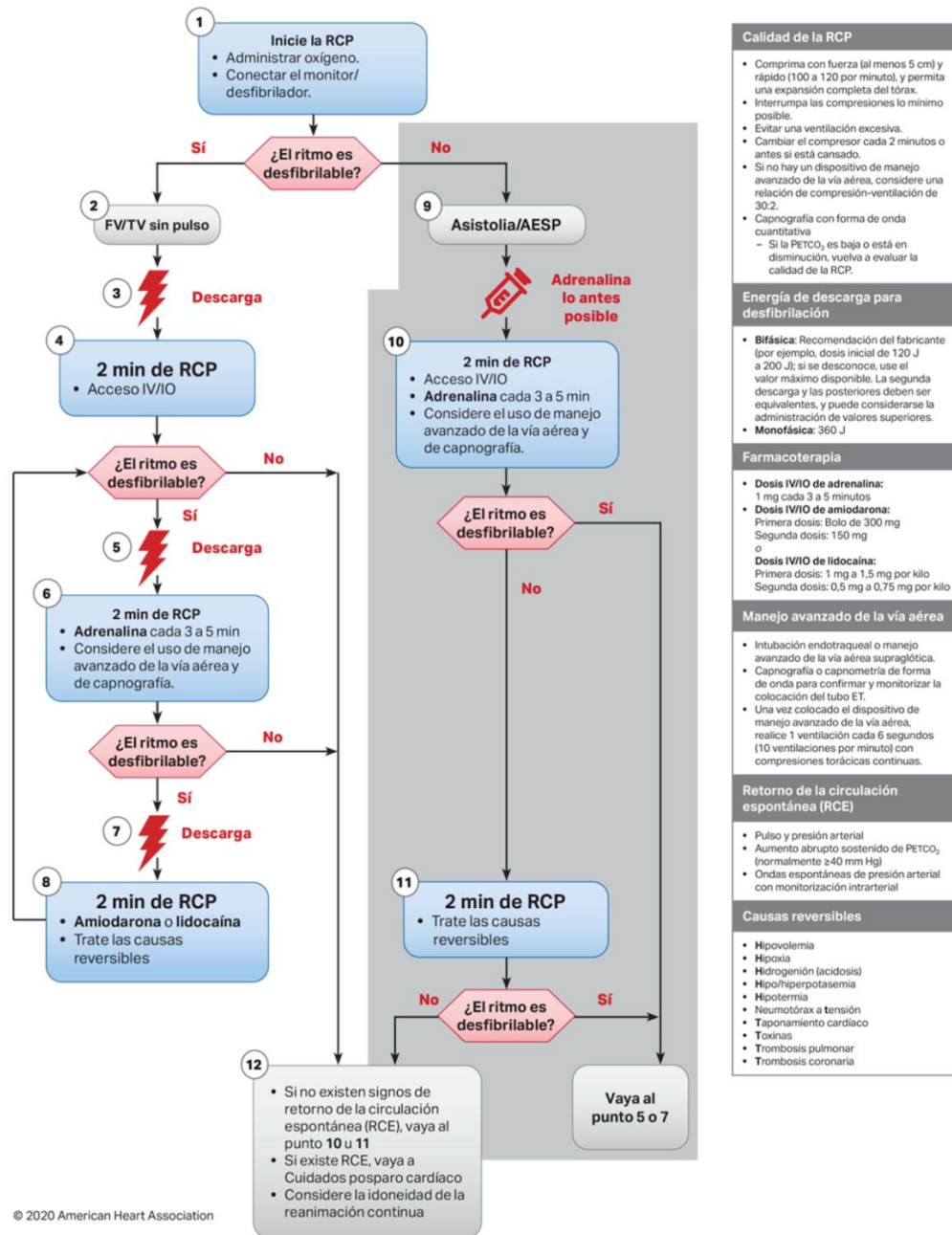
XI. ANEXOS.

Anexo 1: Cadena de supervivencia. Guía AHA 2020.



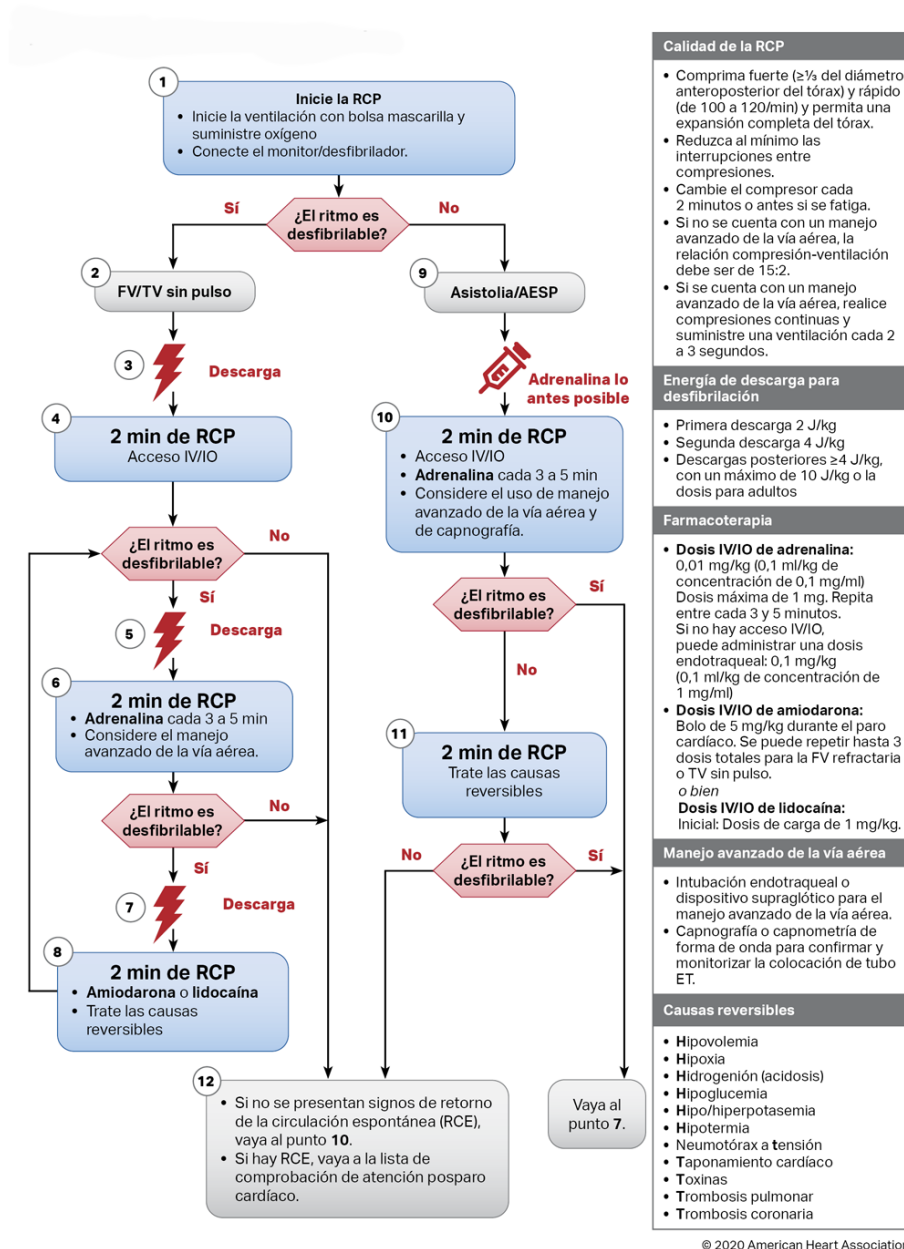
	PROTOCOLO MANEJO AVANZADO DE PARO CARDIORESPIRATORIO	Código:	GCL 1.5
		Fecha:	Mayo 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Julio de 2028
		Página:	Página 15 de 19

Anexo 2: Algoritmo de paro cardíaco en adultos secuencia de FV/TV sin pulso ACLS. Guía AHA 2020.



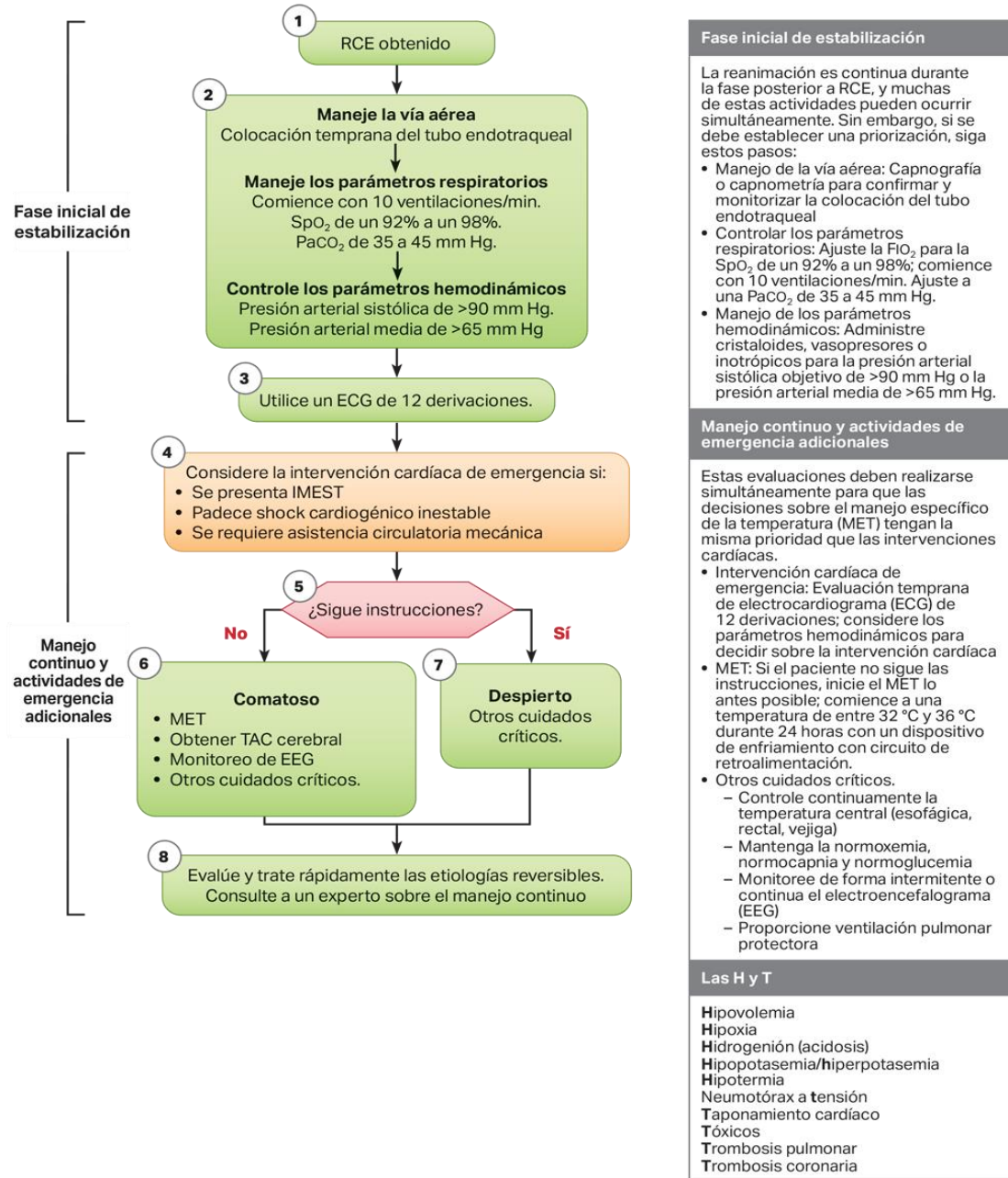
	PROTOCOLO MANEJO AVANZADO DE PARO CARDIORESPIRATORIO	Código:	GCL 1.5
		Fecha:	Mayo 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Julio de 2028
		Página:	Página 16 de 19

Anexo 3: Algoritmo de paro cardíaco en niños secuencia de FV/TV sin pulso PALS. Guía AHA 2020.



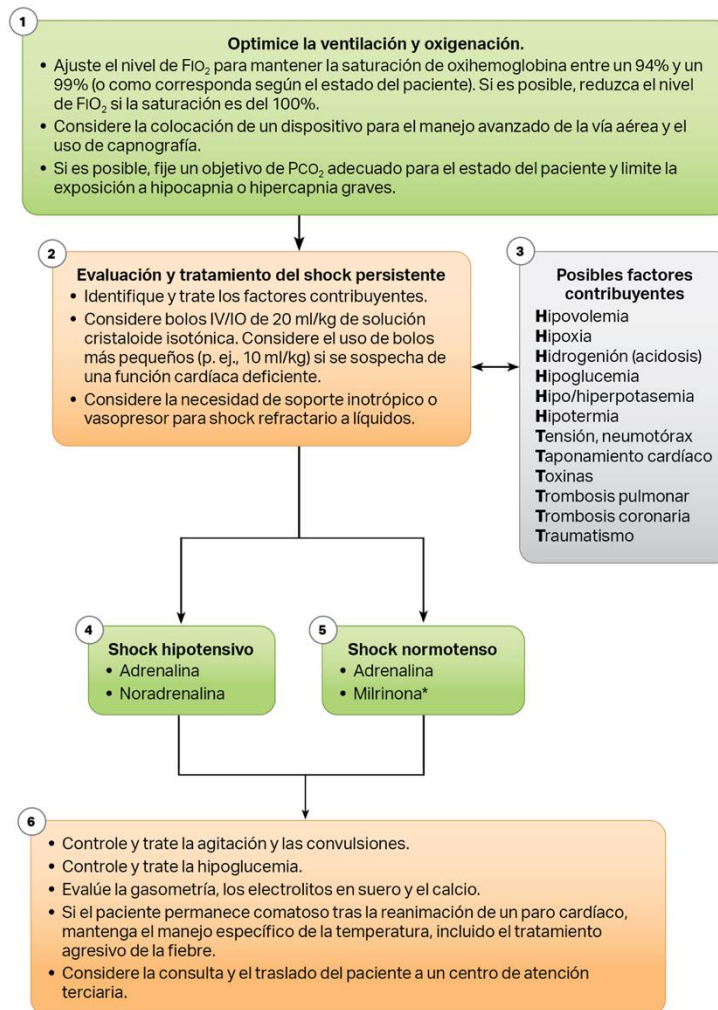
	PROTOCOLO MANEJO AVANZADO DE PARO CARDIORESPIRATORIO	Código:	GCL 1.5
		Fecha:	Mayo 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Julio de 2028
		Página:	Página 17 de 19

Anexo 4: Algoritmo manejo post paro cardiaco. Guía AHA 2020.



	PROTOCOLO MANEJO AVANZADO DE PARO CARDIORESPIRATORIO	Código:	GCL 1.5
		Fecha:	Mayo 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Julio de 2028
		Página:	Página 18 de 19

Anexo 5: Algoritmo del manejo del shock tras el retorno de la circulación espontánea SVAP/PALS. Guía AHA 2020



*La milrinona puede causar hipotensión, por ende, su uso e iniciación deben reservarse, generalmente, a quienes tengan experiencia tanto en ello como en sus efectos secundarios (p. ej., el personal de la UCI).

© 2020 American Heart Association

	PROTOCOLO MANEJO AVANZADO DE PARO CARDIORESPIRATORIO	Código:	GCL 1.5
		Fecha:	Mayo 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Julio de 2028
		Página:	Página 19 de 19

Anexo 6: Algoritmo circular de paro cardíaco en adultos. Guía AHA 2020.



Calidad de la RCP • Comprima con fuerza (al menos 5 cm) y rápido (100 a 120 por minuto), y permita una expansión completa del tórax. • Interrumpa las compresiones lo mínimo posible. • Evite una ventilación excesiva. • Cambiar al compresor cada 2 minutos o antes si está cansado. • Si no hay un dispositivo de manejo avanzado de la vía aérea, considere una relación de compresión-ventilación de 30:2. • Capnografía cuantitativa – Si la PETCO₂ es baja o está en disminución, vuelva a evaluar la calidad de la RCP.
Energía de descarga para desfibrilación • Bifásica: Recomendación del fabricante (por ejemplo, dosis inicial de 120 J a 200 J); si se desconoce, use el valor máximo disponible. La segunda descarga y las posteriores deben ser equivalentes, y puede considerarse la administración de valores superiores. • Monofásica: 360 J
Farmacoterapia • Dosis IV/IO de adrenalina: 1 mg cada 3 a 5 minutos • Dosis IV/IO de amiodarona: Primera dosis: Bolo de 300 mg Segunda dosis: 150 mg o • Dosis IV/IO de lidocaína: Primera dosis: 1 mg a 1,5 mg por kilo Segunda dosis: 0,5 mg a 0,75 mg por kilo
Manejo avanzado de la vía aérea • Intubación endotraqueal o colocación de dispositivo supraglótico • Capnografía o capnometría para confirmar y monitorizar la colocación del tubo ET • Una vez colocado el dispositivo de manejo avanzado de la vía aérea, realice 1 ventilación cada 6 segundos (10 ventilaciones por minuto) con compresiones torácicas continuas.
Retorno de la circulación espontánea (RCE) • Pulso y presión arterial • Aumento repentino y sostenido de la PETCO₂ (normalmente de ≥40 mm Hg) • Ondas espontáneas de presión arterial con monitorización intrarterial
Causas reversibles • Hipovolemia • Hipoxia • Hidrogenión (acidosis) • Hipo/hiperpotasemia • Hipotermia • Neumotórax a tensión • Taponamiento cardíaco • Tóxicos • Trombosis pulmonar • Trombosis coronaria